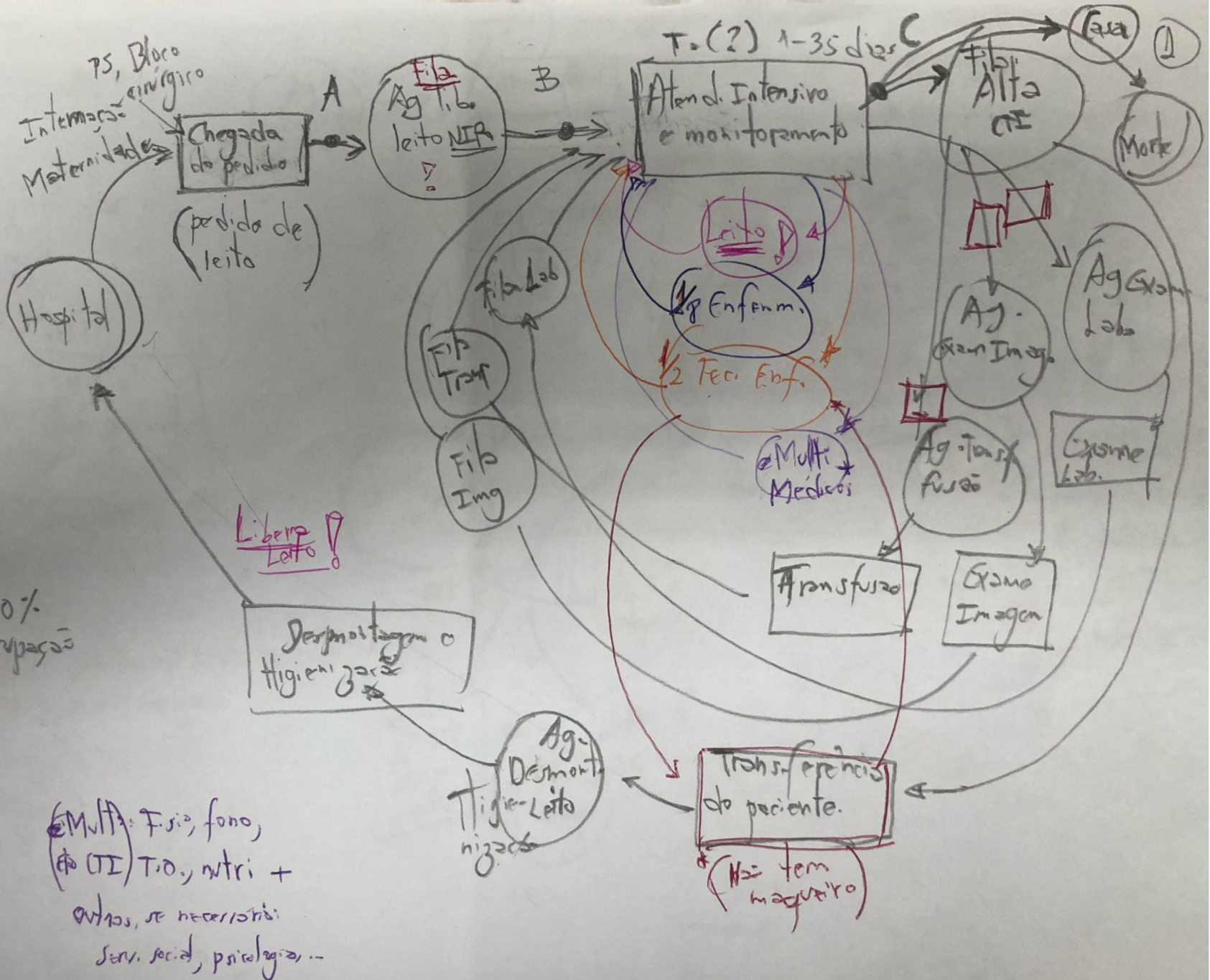


- Patiente
- ~~Leito~~ 35
- Enferm
- Téc. Enf.
- e Multi:

Priorização paciente
(gravidade) %

Se $\frac{35}{\text{Recurso}} < 100\%$
 ↑ Leitor ocupação
 35 (Lote Disponível)

% Coro (raro)
+ Morte
% Alta CIT Hospit
Transf Interna



DCA Clínica Cirúrgica

Paciente hospitalar

~~Wabewidyn-fb~~

1

$$T = 1$$

"Chgado"
Atte perentes
(NIR) - Dados

(x) $\frac{1}{2}$

1

1 Feb

0
r
j

24

—Pic

501 —

1

PM -

1% com anjo (cl)

21

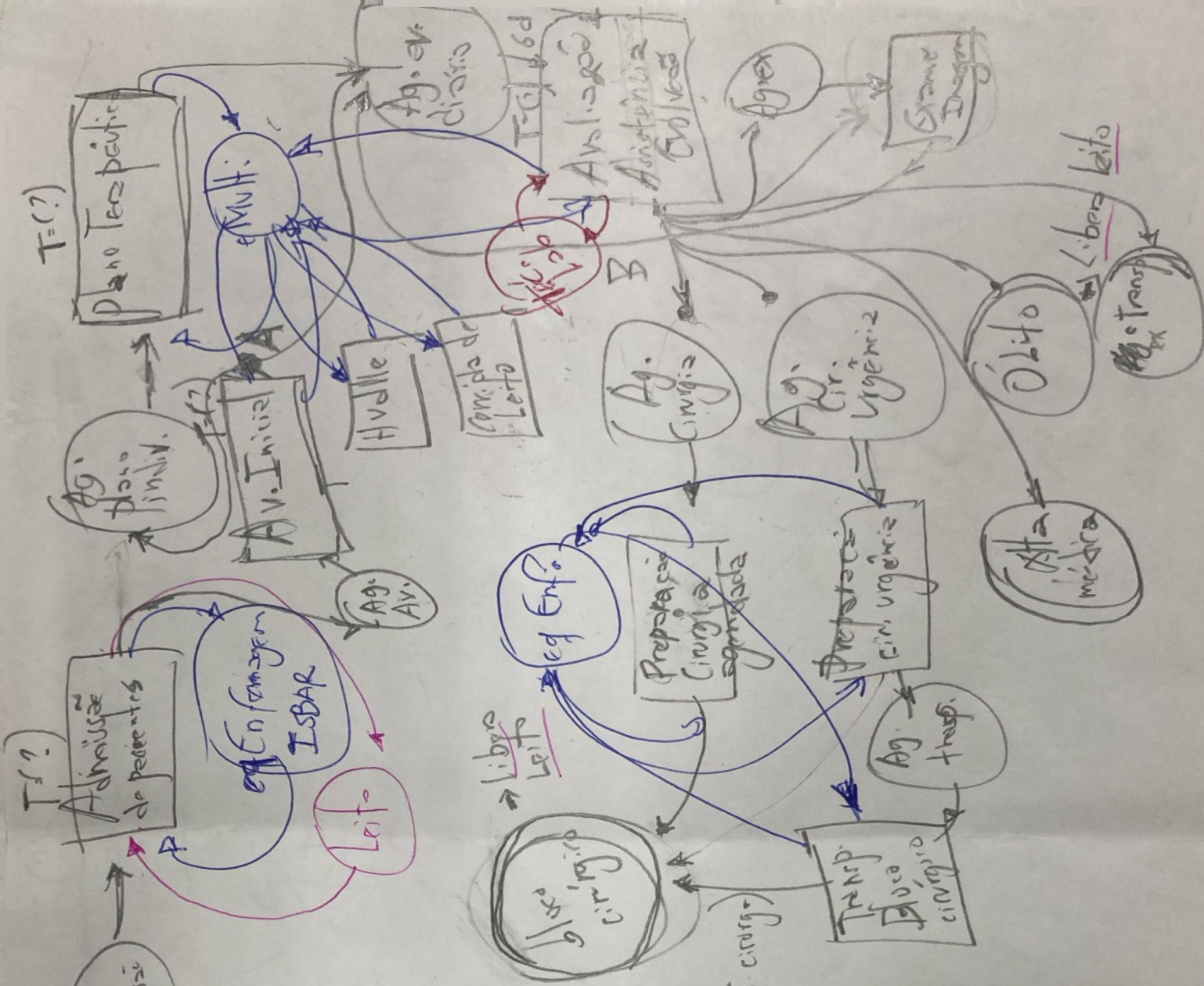
1/2 Cirurgia agendada

1/2 Giorgio wgentio

1/2 0/5 0/5

$\frac{1}{2}$ Temp. Extern

1/4 1/2 1/4



DCA - Clínica Médica

— Paciente

— ~~Leitos~~ (148)

— Eq. Enfermagem

Hosp: 1/1

chegada
paciente

(Ag. Adm)

T- (?)

Admiss-
pariente

Ag. Av.
Inicial

T- (?)

Ar. Inicial

B

Ag. Plano
Terapêuti.

Plano
Terapêuti.

eMulti

Téc. Lab.

00/24h

Ag

Avaliação
Diária

Ag. Av.
diária

Transferência

Alta
Médica

Óbito

Exame
Inspec

eMulti:

A

% Alta
% Exame
% Óbito
% 24h

% Transferência

B

Tempo de TI
informação
TI = TI - 24h

DCA - Centro Cirúrgico

- Paciente Emergente (RPA)
- Paciente Eletivo (Hospital)
- Paciente Urgente Hospital

- Tec. Enfermagem
Enfermeira

- Médico

- Salas de cirurgia (5)
- Sala urgência/emerg. (onda) (1)

- Instrumentador

- Leitor RPA (Prep. Pós Anestésico)

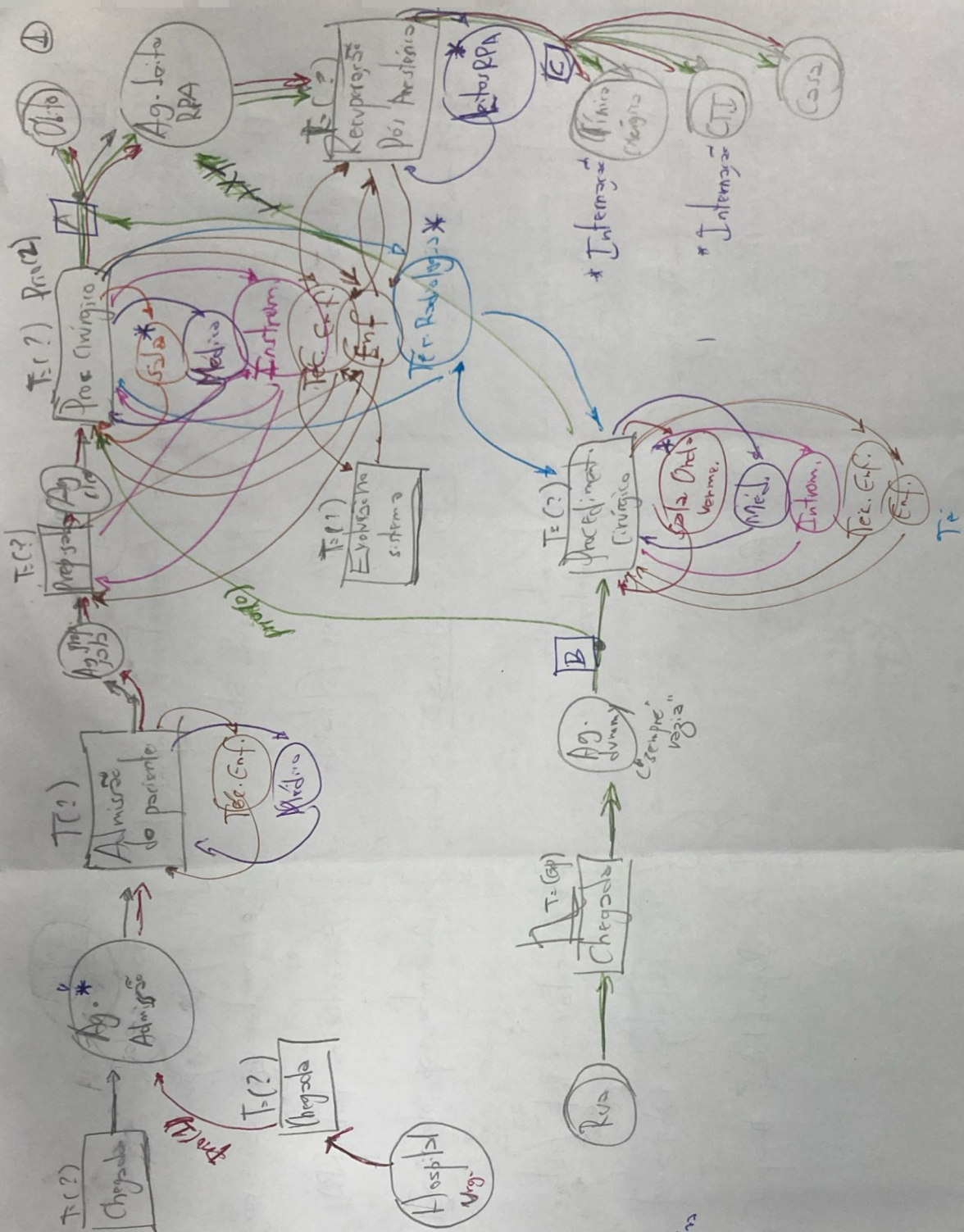
- Tec. Radiologia

A. Dev. Prob.
% RPA
% Obto

Dr. Dev. Cond.
Sala Vermelha
Se filo Pac. Cir. so
Então Solo Pac. cir. eletiva

Ci. Dev. Pub.

% Clínica cirúrgica
% CTI
% Casa



Problemas

- Área de espera (fila) pequena p/ pacientes e acompanhantes
- N.º salas cirúrgicas insuficiente p/ demanda atual
- Superlotação frequente na sala RPA, por falta de leitos
- RPA → Internação, mas n.º leitos de internação é baixo
- Muitas emergências geram → (encolamento de cirurgias eletivas + falta de leitos/sala
- Falta ter. em Radiologia (Recurso) dedicado
- Alto absenteísmo da equipe de enfermagem

Soluções

- } Tamanho da área de espera de pacientes
- } Aumentar ~~de~~ salas cirúrgicas
- } Aumentar n.º leitos RPA
- } Aumentar cap. internação (leitos)
- } Aumentar n.º leitos/sala
- } Tec. Radiologia + disponível
- } Aumentar disponibilidade da equipe Enfermagem

DCA - Exame Imagem

- Exames
- Pacientes
- Médico Radiologista / Espec.
- Aux. Adm.
- Tomografia
- Raio X
- Ultrassom
- Eco-cardiograma
- Endoscópio (ex. end.)
- Duplex (Ultrassom + Doppler)
- Téc. Radiologia / Téc. Enferm.
- Téc. Enfermagem
- Anestesiistas

A: Desvio prob

- ✓ Agendamento
- ✓ Urgente + Agendado previamente

C: Desvio Prob

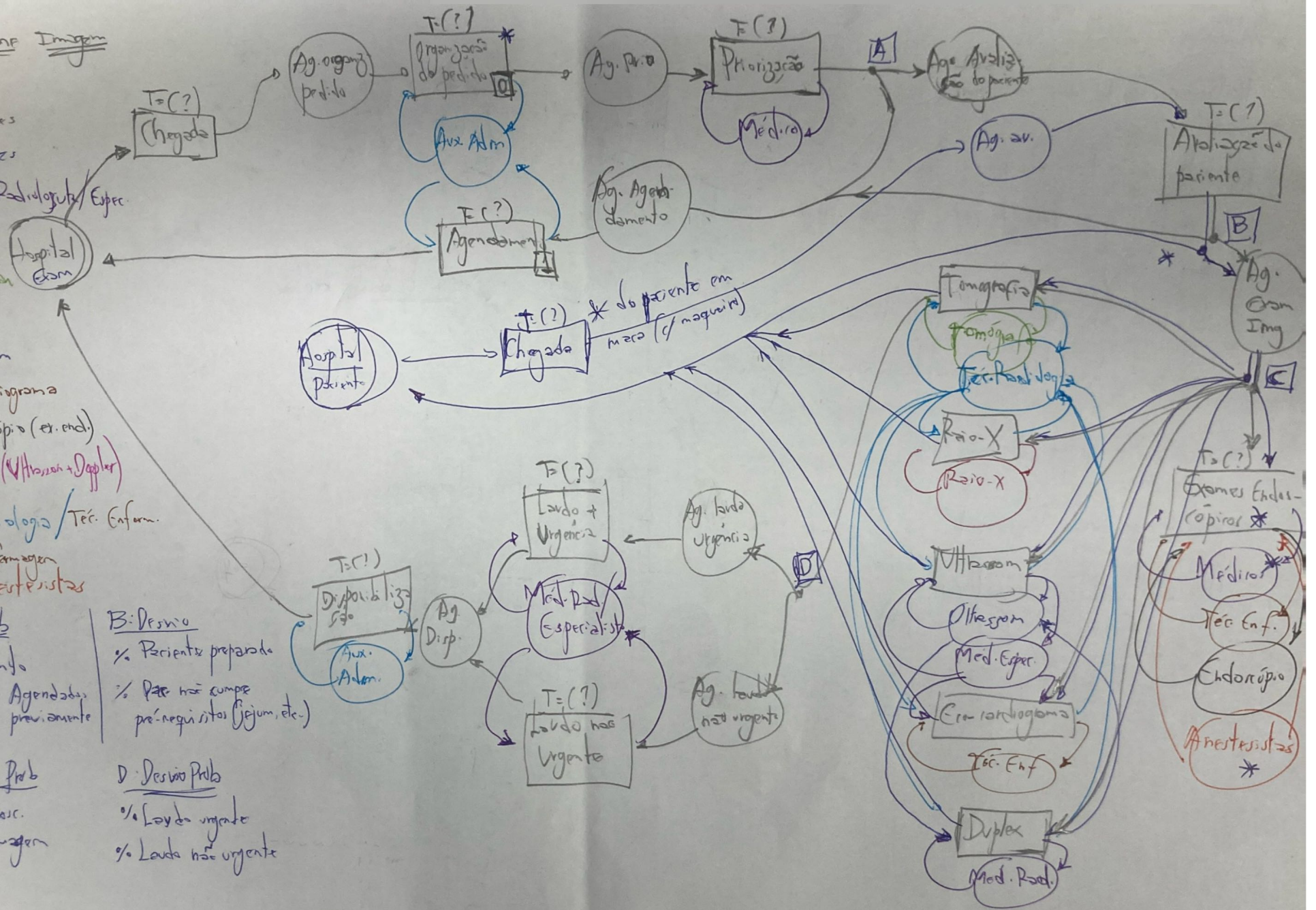
- ✓ Exam. Endosc.
- ✓ Exam. Imagem

B: Desvio

- ✓ Paciente preparado
- ✓ Pac. não cumpre pré-requisitos (jejum, etc.)

D: Desvio Prob

- ✓ Leve não urgente
- ✓ Leve não urgente



* Problemas

- Pedidos duplicados

o Hospital não tem máquina, então enfermeiro é quem tem que transportar, quando tem disponibilidade. x.g.

o (Nahora do almoço, ninguém leva, ... (Prioridade))
mas depois todos levam simultaneamente. (congestionamento)

o Ausência de equipe de transporte

o Preparo inadequado do paciente

o Falta de médicos e anestesistas
(pro) (endoscopia)

Cenários

} Tempo de organização dos pedidos reduzido, se não houver esses problemas

} Máquinas, em quantidade certa

} ↑ x pacientes adequados

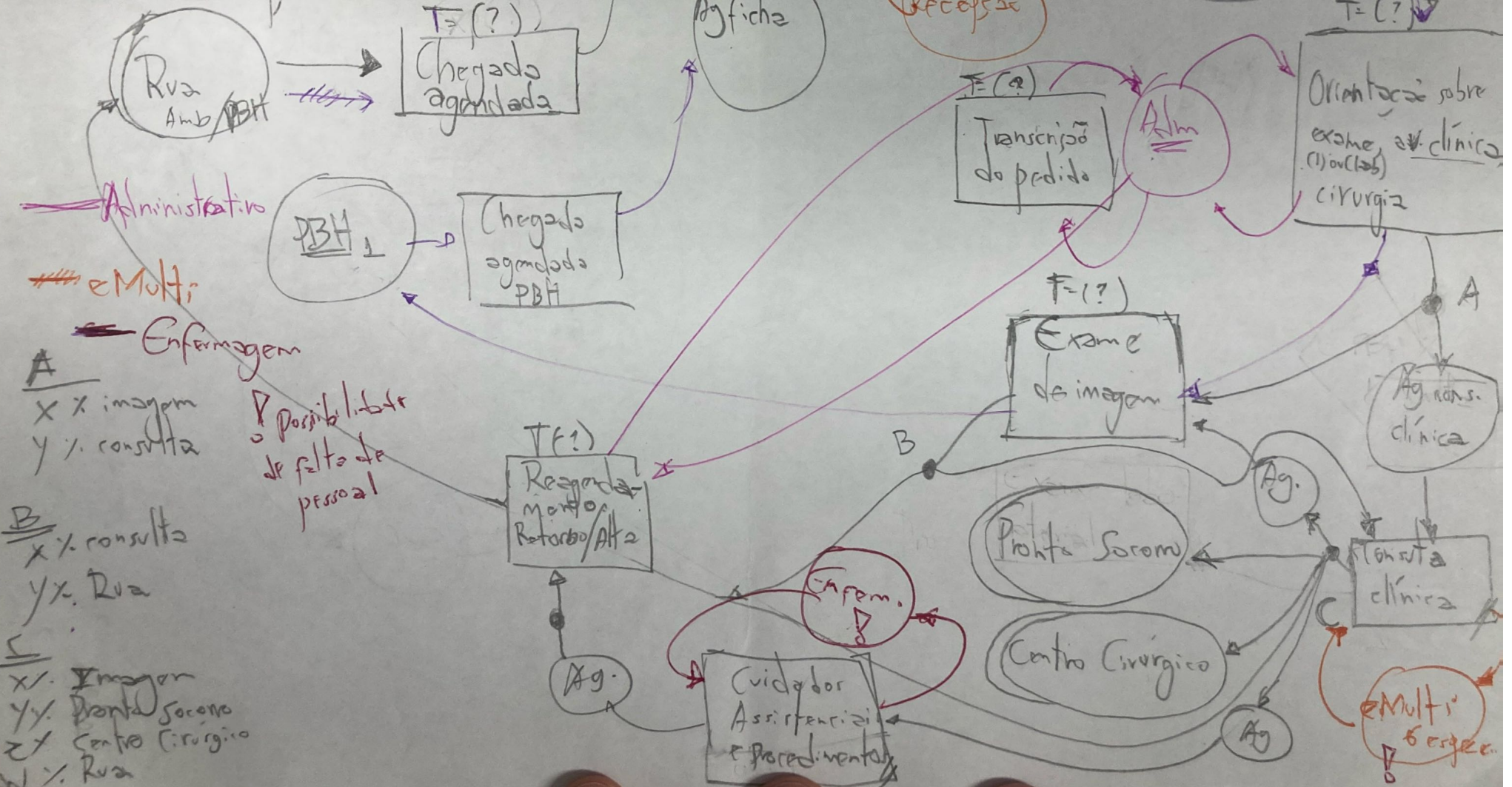
} ↑ sup. médicos e anestesistas

DCA - Ambulatório

— Paciente Externo PBH
== Paciente Ambulatorio

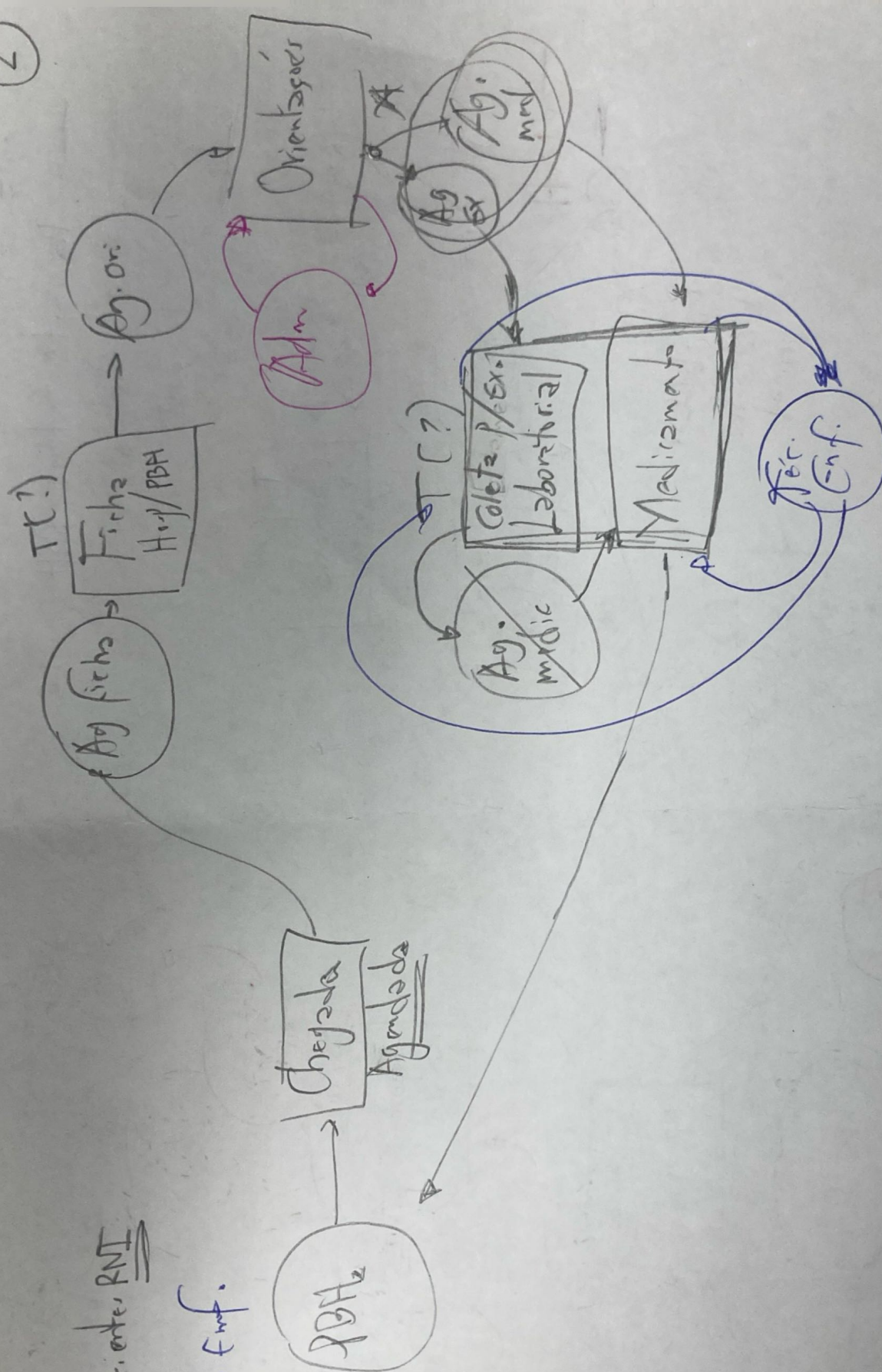
~~xxxxx~~ Paciente RNI

~~000~~ Recepte



(2)

For. Fin.



DCA - Ambulatório

- Paciente Ambulatório (agendado) -

- Paciente Internado (hospital) -

- Paciente externo PBH -

- Enfermagem (P. possib. falta de pessoal)

- Equipe Administrativa

- e Multi

- Paciente RNT

- Eq. Adm. Pac. RNT

A: Desv. prob.

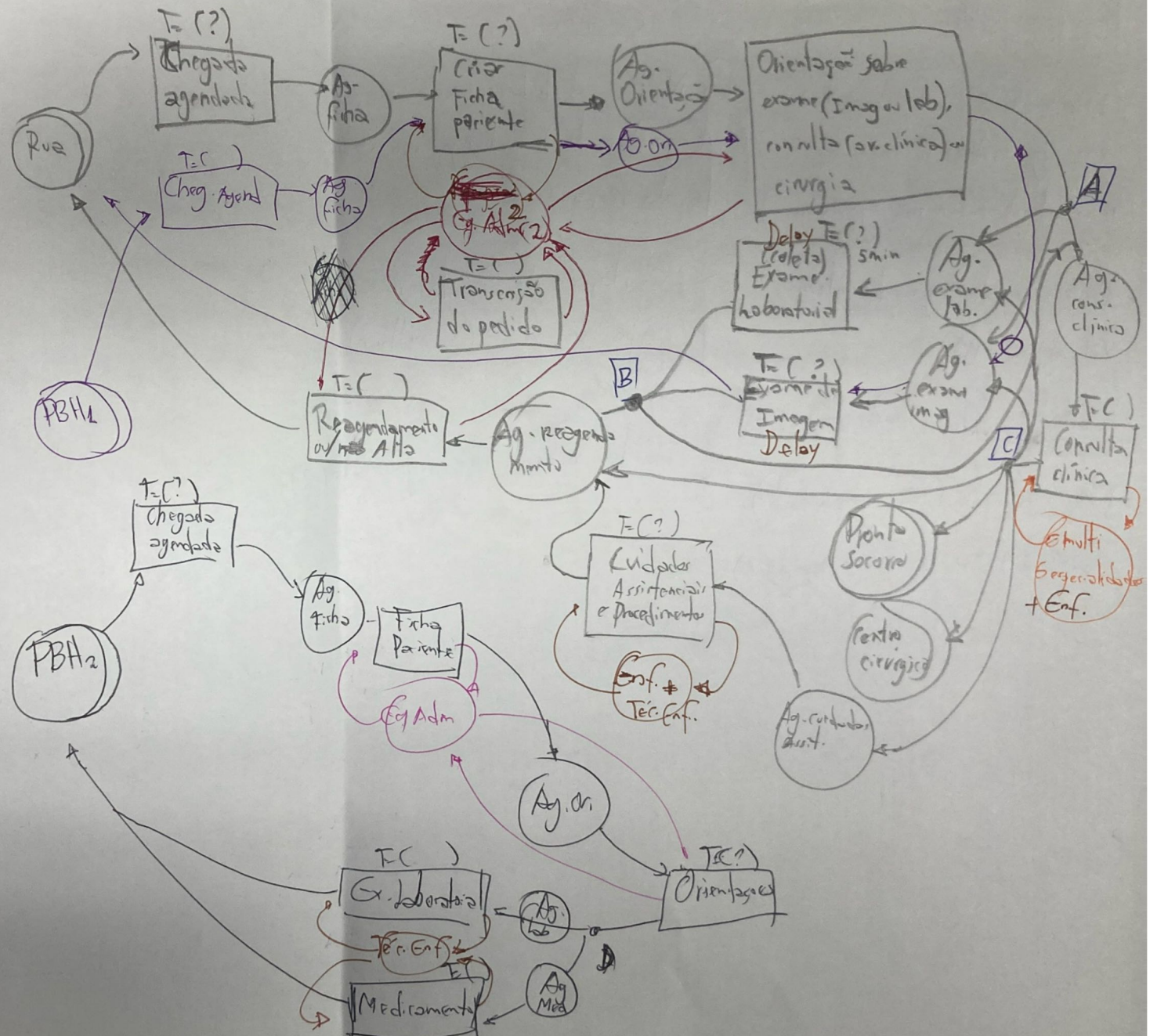
B: Desv. Prob

✓ Consult. cli
✓ Imagem Ex. ~~+~~
✓ Ex. lab

✓ Reagend/Alto
✓ Consulta

C: Desv. Prob

✓ Exam.
✓ Img.
✓ Pronto Socorro
✓ Centro Cirúrgico
✓ Unidades Ans (Amb)
✓ Reag/Alto



Principais problemas

- Fluxo e atendimento concentrado em alguns dias e horários.
(...mas atendimentos são agendados...)

- Ausência de regimento interno validado (POP)

- Estrutura física inadequada (?)
~~Ausência~~

- Fila controlada (são agendamentos)

- Sótar pequenas ou poucas equipes (?)

Cenários

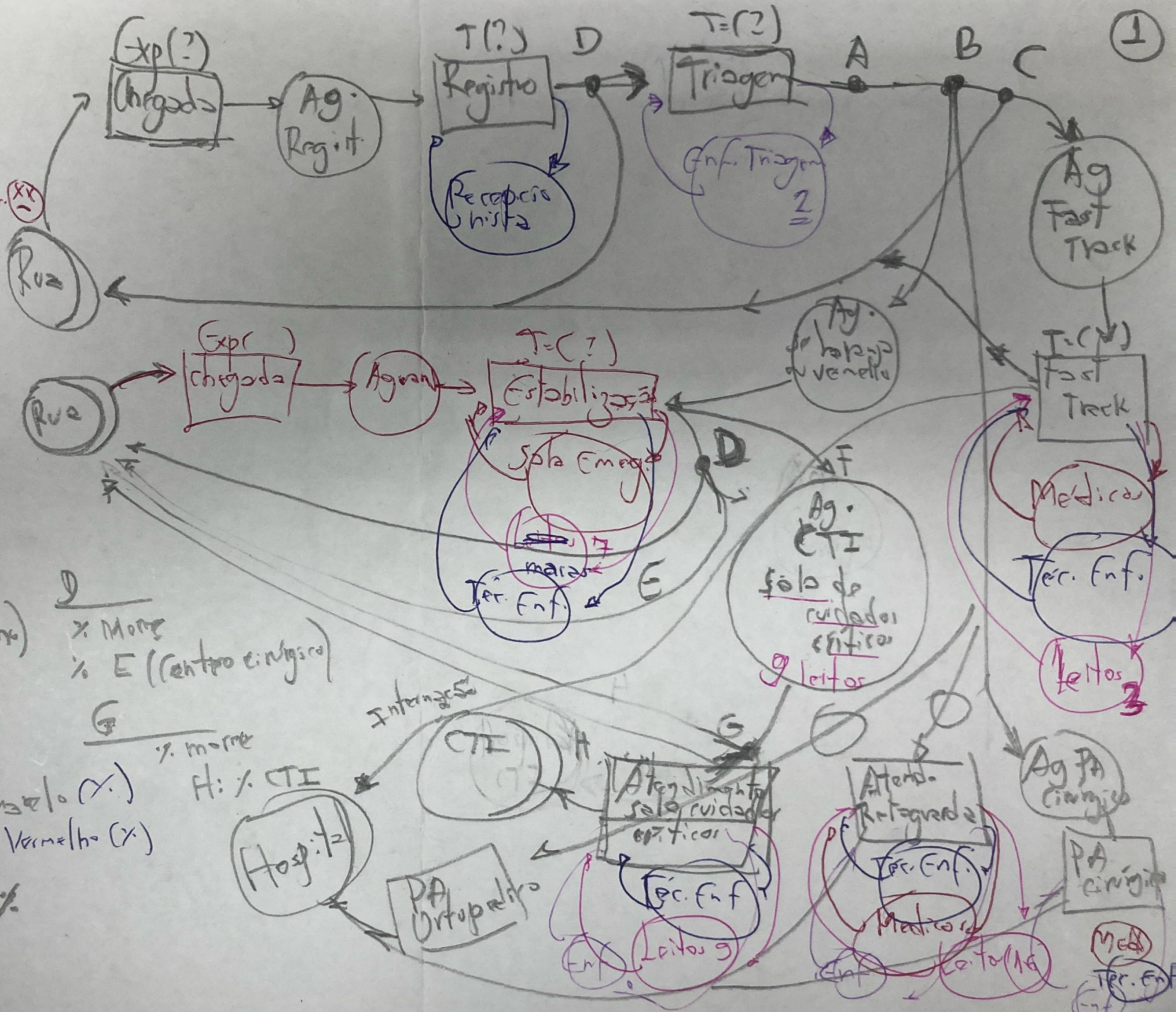
- Melhor distribuição de chegadas (agendamentos) ao longo do dia e da semana.

- Simulação do ambulatório para propor um fluxo (o melhor) p/ POP.

- Projetar aumento da capacidade (?)

DCA - Pronto Socorro

- Paciente
- Paciente Emer. (X)
- Médico
- Enfermeiro
- Téc. Enf.
- Leitos (135)
- Téc. Laboratório
- Recepcionista



oA Pitt. Manchester
 1 a 5 (Azul - Verde)
 Branco (?)

D
 % Mort
 % E (Centro Cirúrgico)

B Decide
 Se Azul, Verde ou Amarelo (X)
 (Laranja ou Vermelho (X))

C De
 % Desiste (>6h) 32%
 D: % Desiste (9%)

DCA - Porto Seguro

- Paciente
- Paciente Emergência
- Médico
- Enfermeiro
- Tér. Enfermagem
- Leitos (135)
- Tér. Laboratório
- Recepcionista
- Poltronas ()

A: Desvio

70% tem alta
X% Internação
Y% morte

B: Desvio

X% tem alta
Y% morte
Z% Intern. outros
W% Internação CTI

Z: Atobito

1..5 (Azul - Vermelho)
Branco(?)

D: Desvio

93% Desiste, 91% segue

E: Desvio

X% Tem Alta
Y% Medicação
Z% Internação (hospital)

F: Desv. Perco

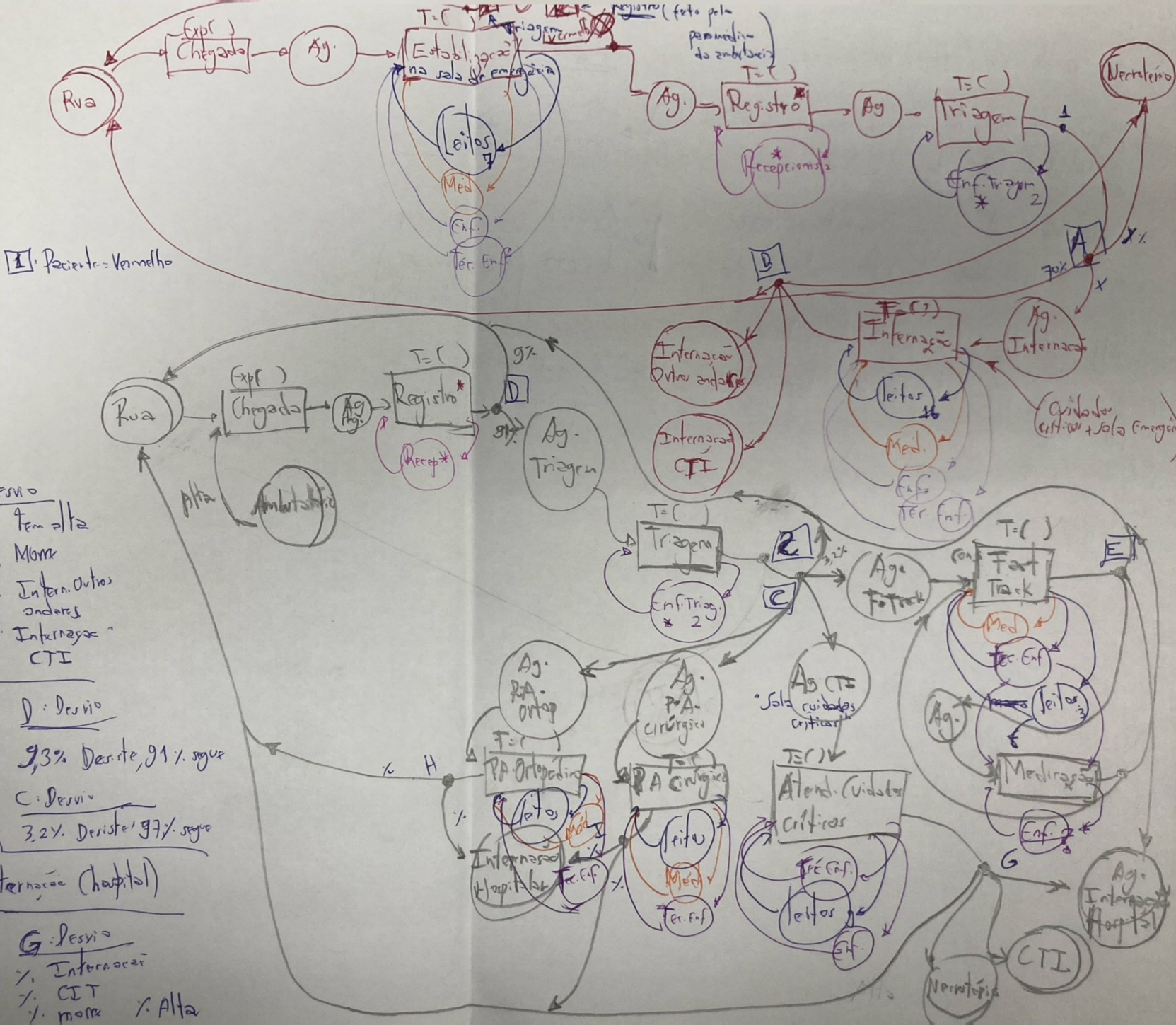
X% Tem alta
Y% Nova consulta

C: Desvio

3,2% Desiste, 97% segue

G: Desvio

% Internação
% CTI
% morte
% Alta



Principais problemas (tema de cenários)

- Maioria dos pacientes verde e amarelo. Deveriam ir p/ UPAS ou UBS, etc.

- Alto índice de encaminhamento p/ CTI, mas a capacidade do CTI muito ocupada

- Alta demanda "de ocupação" da sala de emergência (pacientes vermelho, laranja) (7 leitos)

Cenário 5

Redução de X% de pacientes verde e amarelo

Aumento de X% da cap. do CTI (↑ n.º leitos ou ↑ giro de leitos)

Aumento # leitos de emergência (sala de espera?)